

УДК: 616.5-006.6-08

Н.Т.Балтабеков**, Г.А.Серикбаев*, Д.А.Тулеуова*, К.К.Смагулова*, Р.З.Абдрахманов*, А.К. Туманова*,
А.Н.Қурманалиев*, Н.Ю.Насрытдинова*

*Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии МЗ

**Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Адьювантная терапия меланомы кожи с использованием интерферона альфа и надерина. Протокол клинического исследования ЕАФО

Аннотация. Работа посвящена послеоперационной адьювантной терапии меланомы кожи. 2012 году в Казахстане под контролем Каз НИИ онкологии и радиологии Евразийской Ассоциации Онкологов (ЕАФО) начато многоцентровое контролируемое, клиническое исследование по определению эффективности использования интерферона альфа и надерина при меланоме кожи промежуточного и высокого риска прогрессирования.

Ключевые слова: меланома, интерферон альфа, надерин.

Актуальность

Меланома кожи является чрезвычайно злокачественной опухолью и самой частой причиной смерти среди всех болезней кожи. (Лемехов В. Т., 2004; Балтабеков Н.Т., 2009).

Хирургическое вмешательство остается основным методом лечения первичной меланомы кожи. Однако результаты хирургического лечения зависят от стадии основного процесса: глубины инвазии слоев кожи, наличия внутрикожных и регионарных метастазов (Eugermont A.M.M., 1998; Демидов Л.В., 2004, Коровин С.М., 2008). При ранней 1-А стадии 80-90% больных проживают 10-летний рубеж без проявления болезни (Balch C.M., 1992; Анисимов В.В., 2000; Демидов Л.В., 2004).

При 2В и 3 стадии, когда поражаются глубокие слои кожи или имеются метастазы в лимфатические узлы, 50-60% больных погибают в течение первых двух-трех лет с начала заболевания (Balch C.M., 1992; Балтабеков Н.Т., 2009).

Таким образом, проблема снижения риска развития рецидива или метастазирования после хирургического удаления опухоли и ее метастазов в регионарные лимфатические узлы занимает важное место и привлекает большое внимание онкологов (Демидов Л.В., Харкевич Т.Ю., 2004).

Основной целью профилактической или адьювантной терапии является уничтожение или длительное подавление микрометастазов меланомы после хирургического удаления опухоли (Коровин С.И., 2013).

Главным критерием эффективности адьювантного лечения является уменьшение развития рецидивов болезни и, как следствие этого, увеличение безрецидивной и общей выживаемости жизни больных (Kirkwood J.M. et al., 1994; Agavalla C., 2013).

С профилактической целью при меланоме кожи

применяются различные виды адьювантной терапии, включая химиотерапию, иммунотерапию: левомизалон, вакцина БЦЖ, интерфероны, нуклеиновые кислоты (Балтабеков Н.Т., 2009).

По данным литературы считается, что наиболее активным препаратом для лечения диссеминированной меланомы кожи является дакарбазин, и его эффективность уже в течение 30 лет считается «эталонной» (Quirt J.C. et al., 1991).

Однако эффективность дакарбамина при использовании его в адьювантном режиме после условно радикального хирургического лечения оказалась неоднозначной, и результаты многоцентровых рандомизированных исследований не выявили улучшения выживаемости (Rivers Y.K., 1996; Демидов Л.В., 2004).

Так анализ исследований, проведенных в США Центральной онкологической группой по эффективности дакарбамина в адьювантном режиме выявил даже уменьшение результатов по сравнению с только хирургическим лечением (Харкевич Т.Ю., 2004).

Важнейшей составляющей лечения меланомы кожи является иммунотерапия (Демидов Л.В., 2004). Необходимость использования иммунотерапии была вызвана тем, что многие авторы, которые использовали системную химиотерапию, обнаружили статистически достоверную связь между иммунодепрессией, обусловленной применением химиопрепаратов и ухудшением отдаленных результатов лечения (Кузнецов В.П., 2002; Харкевич Т.Ю., 2004).

Так по данным Кузнецова В.П. (2002) у меланомы кожи отмечаются четкие признаки влияния иммунной системы на развитие опухоли; полная или частичная самостоятельная регрессия опухоли, метастатические очаги без выявления первичной опухоли, лимфоидная инфильтрация опухолевой ткани, прогрессирование процесса на фоне снижения иммунитета (Кузнецов В.П. 2002).

По данным литературы для проведения адьювантной иммунотерапии используются такие препараты как левизол, вакцина БЦЖ, интерлейкины, интерфероны альфа два «А», альфа два «В», нуклеиновые кислоты – деринат натрия, надерин (Балтабеков Н.Т., 2012).

Наибольшее количество рандомизированных исследований в мире было посвящено использованию рекомбинантных интерферонов альфа.

Так с начала 80-ых годов ушедшего столетия было проведено большое количество проспективных кооперированных протоколов, выполненных ведущими

исследовательскими группами США и Европы с целью изучения эффективности различных режимов двух основных препаратов р ИФ а-2а и а-2β у больных меланомой кожи II и III стадий (Демидов Л.В., 2004).

Полученные данные рандомизированных исследований достаточно противоречивы и не позволяют окончательно оценить роль и место адъювантной иммунотерапии р ИФ-а в профилактике рецидива и прогрессирования заболевания у больных с меланомой кожи II и III стадии. Все это привело к тому, что несмотря на определенные успехи, профилактическая иммунотерапия интерфероном альфа до сих пор не является официально утвержденным видом адъювантной терапии меланомой кожи промежуточного и высокого риска в странах Европы и СНГ.

Так по данным Европейской Ассоциации медицинских онкологов на сегодняшний день нет стандартной схемы адъювантного лечения меланомы кожи

При этом высокодозный режим иммунотерапии интерфероном альфа по 18мл МЕ на м² (30-36 мл МЕ) ежедневно в течении года, используемый в США не нашел широкого применения в Европе и странах СНГ, из-за токсичности и высокой стоимости лечения. В то же время используемые в Европе низкодозные режимы NFα оказались не эффективными при высоком риске прогрессирования заболевания.

Для определения единой тактики в КазНИИ онкологии в 2012 году начато многоцентровое контролируемое клиническое исследование по изучению эффективности адъювантной иммунотерапии интерфероном альфа и надерина с участием экспертной группы ЕАФО.

Протокол исследования был обсужден и утвержден:

1. Международная конференция ЕАФО- Адъювантная терапия меланомы кожи. г. Москва, июнь 2011г.

2. На конференции «Использование интрона а при меланоме и раке кожи» г.Алматы, декабрь 2011г.

3. На заседании рабочей группы сотрудников химиотерапии, онкоурологии и отделения опухолей костей и мягких тканей КазНИИ онкологии и радиологии г. Алматы январь 2012г.

4. На ученом Совете Казахского научно исследовательского института онкологии и радиологии г. Алматы февраль, март, 2012г.

Экспертная группа исследования

Егермонт А. – Генеральный Директор Онкологического центра имени Густава Русси. Ведущий специалист EORTC в лечении меланом и сарком.г. Париж, Франция.

Агарвала С. (США) – директор программы по иммунологии в онкологическом центре св Луи. Руководитель исследования E 1697 меланомного комитета Восточной Кооперированной онкологической группы ECOG

Демидов Л.В. (Россия) – руководитель отделения биотерапии НИИ клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина г. Москва. Председатель Российского Экспертного Совета по меланоме.

Сомасундранан С. (Индия) – директор ЕАФО (Ассоциация Онкологов Европы и Азии)

Цель исследования

- улучшение результатов хирургического лечения меланомы кожи.

Задачи исследования

Оценить эффективность иммунотерапии интерфероном альфа в сочетании с надеринем при меланоме кожи промежуточного и высокого риска в адъювантном режиме.

Определить результаты самостоятельной иммунотерапии интерфероном альфа при меланоме кожи промежуточного и высокого риска в адъювантном режиме.

Изучить при меланоме кожи промежуточного риска эффективность самостоятельного применения надерина в адъювантном режиме.

Дать оценку динамике показателей клеточного иммунитета и уровня онкомаркера S-100 в процессе лечения меланомы кожи высокого и промежуточного риска прогрессирования.

На основании полученных результатов заявить наиболее эффективную схему адъювантного лечения с учетом основных прогностических факторов.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования являются больные меланомой кожи с гистологическим верифицированным диагнозом после хирургического удаления опухоли и ее регионарных метастазов.

Критерии включения:

- гистологический верифицированный диагноз

- операбельная форма

T2-4N0 M 0 – промежуточный риск

T1-4N 1M 0 – высокий риск;

- статус по шкале B03<2, активность по шкале Карновского более 70%

- отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний в стадии декомпенсации

- возраст от 18 до 80 лет.

Методы диагностики меланомы

Опрос (наличие симптомов малигнизации)

Обычный осмотр (правильно ABCDE)

Дермотоскопия

Кровь на S-100, СД4/СД8.

Открытая тотальная кожная биопсия под общим обезболиванием, с цитологическим и гистологическим исследованием, с определенном степени инвазии по Кларку и Бреслау.

Методы лечения меланомы кожи

Первым этапом лечения для всех групп было хирургическое удаление основного очага и увеличенных регионарных лимфатических узлов под общей анестезией.

Затем в зависимости от стадии опухолевого процесса и вида адъювантного лечения больные были разбиты путем рандомизации на следующие группы.

I Меланомы высокого риска

Метастазирования T1-4N 1-2M 0, или T1-4N 0M 0 местный или регионарный рецидив после хирургического лечения.

Основная группа: интрон А+ надерин индукционный курс NFA 18мл МЕ внутри можно с интервалом 7 дней, в течении одного месяца и надерин по 2др. per oss 1 раз в день, поддерживающая терапия интерферон альфа по 9мл МЕ внутривенно один раз в месяц в сочетании с ежедневным приемом надерина по 2 дражке per oss в течение года

Основная группа интрон А(NF) индукционный курс только NF 18мл ME внутривенно, с интервалом 7 дней в течении месяца, затем поддерживающая терапия NF по 9мл ME 1 раз в месяц в течении года.

Контрольная группа - полихимиотерапия по схеме дакарбазин 1400мл, цисплатин 50мл внутривенно 6 курсов с интервалом 21 день

II меланома промежуточного риска

Метастазирования T1-4N 0M 0

Основная группа: интрон А+надерин NF18мл ME N4 с интервалом 7 дней, затем 9 мл ME в/к с интервалом месяц в течении года + надерин по 2 дражке 1 раз в день в течении года

2 Основная группа: интрон А(NF) 18 мл ME N4, с интервалом 7 дней, затем 9мл ME в/к с интервалом месяц в течении года

3 Контрольная группа – надерин по 2 дражке 1 раз в день в течение года.

Критерии оценки эффективности проводимого лечения:

- 1 . Увеличение без рецидивного периода
- 2 . Увеличение общей выживаемости
- 3 . Динамика маркеров опухолевого процесса – S- 100, CD 4/CD 8
- 4 . Качество жизни больных во время лечения
- 5 . Уровень лейкопении, охват лечением

Ожидаемые результаты

1. Высокие дозы интерферона в сочетании с надерин сохраняют антипролиферативные свойства – но за счет надерина легче переносятся, ожидается значительное снижение токсичности, лейкопении, иммунодефицита.

2. Сочетание ИФальфа и надерина позволит увеличить без рецидивный период в среднем на 30%, по сравнению с полихимиотерапией и чисто хирургическим лечением.

3. Снижение финансовых затрат по сравнению с существующими в США и Европе стандартами адъювантного лечения в 7-8 раз.

4. Повышение качества жизни пролеченных больных – возможность получения терапии амбулаторно.

Предварительные результаты

В период с 2012 года по 2013 начато исследование у 63 пациентов с меланомой кожи.

Из 63 больных 9 исключены из протокола из-за нарушения режима и схем лечения и у одного пациента, начавшего лечение при пересмотре гистологии и ИТХ диагноз меланома не подтвердился, выявлено Т-клеточная лимфома кожи.

Из запланированных 7 клинических центров в настоящее время проводится в 4, включая КазНИИ О и Р, ООД ЮКОг.Шымкент, онкологический центр медицинской Академии г.Актюбинск, Региональный Областной Онкологический диспансер г.Алматинской области.

Набор клинического материала продолжается до декабря 2014 года.

Выводы

1 Адъювантная терапия меланомы кожи по данным литературы остается не решенной проблемой клинической онкологии.

2 Данные зарубежных рандомизированных исследований США и Европы разноречивы, поэтому отсутствует единый стандарт адъювантной терапии меланомы кожи промежуточного и высокого риска.

3 Наиболее перспективным направлением адъювантной терапии меланомы кожи по данным ЕАФО является комбинация интерферона альфа и надерина, позволяющая снизить токсичность, повысить эффективность и переносимость высоких доз интерферона альфа.

4 Меланома кожи – иммунозависимая опухоль и требует контроля за уровнем клеточного иммунитета до, во время и после лечения, для определения эффективности терапии и своевременного выявления прогрессирования заболевания, особенно в сочетании с определением уровня онкологического маркера меланомы S-100.

5 Для определения наиболее оптимальных схем лечения и выработки единого стандарта необходимо проведение в Казахстане собственных многоцентровых, контролируемых, клинических исследований, включая КазНИИ Онкологии и Радиологии и областные онкологические диспансеры.

Список литературы

- 1 Лемехов В.Т.. Эпидемиология, факторы риска, скрининг меланомы кожи // Практическая онкология: избр. лекции / под. ред. С.А. Тюляндина и В.М. Моисеенко. – СПб.: Центр ТОММ, 2004. – 513 с.
- 2 Балтабеков Н.Т. Пути улучшения диагностики и лечения меланомы кожи: дис...д-ра мед. наук: 14.00.14 – Алматы, 2009-93 с.
- 3 Eygermont A.M. Strategy of the EORTC-MCG trial programme for adjuvant treatment of moderate-risk melanoma // Europ. J. Cancer. – 1998. – Vol. 34. – P. 822-826.
- 4 Balch C. Metall. Cutaneous Melanoma (second edition). – Philadelphia: J. B. Lippincott, 1992-583 p.
- 5 Анисимов В.В. Меланома кожи (перспективы улучшения диагностики и лечения: дис... д-ра мед. наук: 14.00.14 – СПб.: 2000. – 97 с.
- 6 Демидов Л.В., Харкевич Г.Ю. Адъювантное лечение больных меланомой кожи // Практическая онкология: избр. лекции / под. ред. А.С. Тюляндина и В.Н. Моисеенко. – СПб.: Центр ТОММ, 2004. – С. 573-583.
- 7 Коровин С.И., Кукушкина М.Н., Толстомятов Б.А. Результаты лечения больных с метастазами меланомы кожи // Мат. V съезда онкологов стран СНГ, - Ташкент, 2008. -341 с
- 8 Kirkwood J.M., Strawderman M.C.H., Ernstoff M.S.. Interferon alfa – 2 β adjuvant therapy of high-risk resected cutaneous melanoma: The Eastern Cooperative Oncology Group Trial EST 1684 // J. Clin. Oncology. – 1996. – Vol. 14- P. 7-17.
- 9 Quirt J.C., Shelly W.E. Pater J.L. Biologic properties of recombinant alfa interferons: 40 th anniversary of the discovery of interferons // Cancer Res. – 1998. – Vol. 58 – P. 2489.
- 10 Кузнецов В.П., Кошенкова О.А., Беляев Д.А. Процентное соотношение общих иммуноглобулинов как важный критерий иммунологического статуса // Материалы VIII международного конгресса иммунореабилитации.-Канны, – 2002 –С.77.

Тұжырым

Н.Т.Балтабеков, Ф.А.Серікбаев, Д.А.Төлеуова, К.К.Смағұлова, Р.З.Абдрахманов,

А.К.Тұманова, А.Н.Құманалиев, Н.Ю.Насрытдинова
Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті

Тері меланомасына адъювантты терапия интерферон альфа және надеринді қолдану. ЕАФО клиникалық зерттеулерінің қаттамасы

Жұмыстері меланомасына операциядан кейін адъювантты терапиясын қолдану жайында баяндайды. 2012 жылы Қазақстанда ҚазОЖР ғылыми-зерттеу институты Еуразиялық онкологтардың Ассоциациясының (ЕАФО) бақылауымен көпшілік орталықтанған бақылаудағы клиникалық зерттеулер басталды, анықталған әсері жағынан интерферон альфа және надериндітері меланомасына қолданып аралақта жоғары қауіптілікті жоюға жеткізді.

Түйінді сөздер: иммунотерапия, надерин, сүт безінің қатерлі ісігі, иммуноаппшылық, лейкопения, иммунокоррекция.

Summary

N.T.Baltabekov, G.A.Serikbaev, D.A.Tuleuova, K.K.Smagulova, R.Z.Abdrahmanov, A.K.Tumanova, A.K.Kurmanaliev, N.Y.Nasrytdinova

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Kazakh National Medical University im.S.D.Asfendiyarova Graduate School of Public Health

Adjuvant therapy of melanoma with interferon alpha and naderine.

Clinical study protocol EAFO

Work is devoted to post-operative adjuvant therapy of melanoma. In 2012 in Kazakhstan under the control of the Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology of the Eurasian Association of Oncologists (EAFO) initiated a multicenter, controlled clinical trial to determine the effectiveness of the use of interferon alfa and naderineto skin melanoma intermediate and high risk of progression.

Keywords: melanoma, interferon alpha, naderin.